



PROVA OBJETIVA

LÍNGUA PORTUGUESA

PASSO CERTO

O Estatuto do Desarmamento, aprovado no fim do ano, e ainda em fase de regulamentação, surgiu por uma questão de sobrevivência. O contexto que deflagrou o movimento político pelo endurecimento da legislação sobre armas é no mínimo dramático. Em 20 anos, de 1980 a 2000, conforme estudo do IBGE, 600 mil brasileiros foram assassinados, uma média de 30 mil por ano.

Nesse ritmo, a cada dois anos morrem no Brasil, quase sempre a bala, o comparável a todas as perdas de soldados americanos nos 11 anos da guerra no Vietnã. Como pano de fundo da tragédia, estava uma legislação que tratava porte e posse ilegal de armas como contravenção, delito punido com penas alternativas.

O resultado foi a banalização do uso e do porte de armas e, como consequência, milhares de tragédias no cotidiano. Essa banalização impulsionou as estatísticas sobre violência: o número de homicídios, nesse período de vinte anos, aumentou 130%. E pior: a grande maioria das vítimas tem sido de jovens de 15 a 24 anos. Assim, famílias se desestabilizam e o futuro é cortado pela raiz.

O descaso legal com as armas serviu de terreno fértil para a amplificação da violência trazida para a vida brasileira pela expansão do tráfico de drogas. Armas e drogas se complementaram para produzir o atual estado de coisas.

O estatuto pode ter uma outra falha, mas representa o primeiro resultado concreto importante, do ponto de vista legal, da reação da sociedade diante do atual descontrole na segurança pública. Outros passos são necessários. Mas um já foi dado na direção certa.

(O Globo, 6/5/04)

01 - O passo certo a que alude o título é:

- (A) a aprovação do Estatuto do Desarmamento;
- (B) a regulamentação do Estatuto do Desarmamento;
- (C) a reação da sociedade diante da violência;
- (D) a tentativa de controle da segurança pública;
- (E) a não-banalização do uso e do porte de armas.

02 - A tese exposta no texto, em relação ao desarmamento, é a de que:

- (A) deve ser feito, ainda que traga problemas de insegurança;
- (B) não deve ser feito, pois os cidadãos necessitam de proteção;
- (C) o processo está no início, mas está no caminho certo;
- (D) o processo está encerrado, com vantagens para a sociedade;
- (E) o processo é correto e necessita ser aprovado.

03 - A palavra “contexto”, no segmento “O contexto que deflagrou o movimento político pelo endurecimento da legislação sobre armas é no mínimo dramático.” significa:

- (A) o que constitui um texto no seu todo;
- (B) circunstância em que um fato ocorre;
- (C) as relações legais de uma sociedade;
- (D) uma situação difícil ou problemática;
- (E) o que está contido em determinado texto.

04 - “O contexto que deflagrou o movimento político pelo endurecimento da legislação sobre armas é no mínimo dramático”; o comentário correto sobre esse segmento do texto é:

- (A) “dramático” define de forma objetiva a situação descrita;
- (B) “endurecimento” mostra que a legislação anterior era dura em excesso;
- (C) o “movimento político” é consequência do endurecimento na legislação;
- (D) a legislação nova proíbe o uso de armas;
- (E) o drama aludido está na situação social.

05 - Ao dizer que os dados fornecidos estão de acordo com “estudo do IBGE”, o autor do texto pretende:

- (A) indicar que o estudo foi feito no governo anterior;
- (B) demonstrar que as armas têm sido uma preocupação constante;
- (C) dar credibilidade às informações prestadas;
- (D) caracterizar a situação de insegurança como antiga;





PROVA OBJETIVA

(E) mostrar que o Governo se preocupa com a segurança da população.

06 - A comparação de o número de mortos em dois anos no Brasil ser equivalente ao da perda dos soldados americanos na Guerra do Vietnã em 11 anos mostra que:

- (A) a guerra do Vietnã foi bastante cruel para os americanos;
- (B) o número de mortos no Brasil é bem inferior;
- (C) as guerras no Brasil são menos violentas;
- (D) o número de mortes no Brasil é bem mais espantoso;
- (E) os mortos no Brasil perecem por situação menos digna.

07 - Ao utilizar o verbo “assassinar” para designar o modo por que morreram 600 mil brasileiros em 20 anos, o autor do texto quer dizer que essas mortes foram:

- (A) propositais e criminosas;
- (B) acidentais e violentas;
- (C) repentinas e premeditadas;
- (D) casuais e rápidas;
- (E) involuntárias e cruéis.

08 - Ao dizer que houve uma “média de 30 mil (mortes) por ano”, o autor quer dizer que:

- (A) todos os anos morreram mais de 30 mil;
- (B) todos os anos morreram menos de 30 mil;
- (C) todos os anos morreram ao redor de 30 mil;
- (D) todos os anos morreram exatamente 30 mil;
- (E) a média aritmética das mortes por ano é de 30 mil.

09 - O fato de dizer que a legislação anterior tratava porte e posse ilegal de armas como contravenção, mostra que essa legislação precisava de um(a):

- (A) abrandamento;
- (B) endurecimento;
- (C) reconhecimento;
- (D) preservação;
- (E) continuidade.

10 - “Penas alternativas” são penas que:

- (A) fogem das tendências dominantes;

- (B) apresentam rigor exagerado;
- (C) excluem o réu do convívio social;
- (D) levam os réus a presídios de segurança máxima;
- (E) colocam o réu em liberdade condicional.

11 - O texto diz que milhares de tragédias no cotidiano estão relacionados à banalização do uso e do porte de armas; há, assim, entre esses fatos uma relação, respectivamente, de:

- (A) causa/efeito;
- (B) motivação/ação;
- (C) condição/ação;
- (D) consequência/causa;
- (E) fato/explicação.

12 - Quando o texto diz que “o futuro é cortado pela raiz”, quer dizer que:

- (A) a população diminui consideravelmente;
- (B) as famílias se reduzem;
- (C) morrem predominantemente jovens;
- (D) desaparecem trabalhadores e intelectuais;
- (E) só morrem cidadãos responsáveis e produtivos.

13 - Não entra no rol dos argumentos favoráveis ao desarmamento:

- (A) a banalização do uso e do porte de armas;
- (B) o aumento do número de homicídios;
- (C) a morte predominante de jovens de 15 a 24 anos;
- (D) a desestabilização das famílias;
- (E) a expansão do tráfico de drogas.

14 - “O estatuto pode ter uma ou outra falha...”; o segmento tem valor:

- (A) causal;
- (B) comparativo;
- (C) consecutivo;
- (D) concessivo;
- (E) conclusivo.

15 - “Mas um já foi dado na direção certa”; a mesma voz verbal presente nesse segmento do texto repete-se em:

- (A) “O estatuto pode ter uma ou outra falha...”;
- (B) “...600 mil brasileiros foram assassinados,...”;





PROVA OBJETIVA

- (C) “O resultado foi a banalização do uso e do porte de armas...”;
- (D) “...a grande maioria das vítimas tem sido de jovens...”;
- (E) “Outros passos são necessários”.

SUS

16 - Segundo a Lei nº 8080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde (SUS), a participação da iniciativa privada na assistência à saúde é:

- (A) livre;
- (B) obrigatória;
- (C) minoritária;
- (D) prioritária;
- (E) proibida.

17 - Segundo a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 01/2002 –, a responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexidade se traduz, entre outras, nas seguintes atribuições, **EXCETO**:

- (A) definição de normas nacionais;
- (B) definição de incorporação dos procedimentos a serem ofertados à população pelo Sistema Único da Saúde;
- (C) transferência para os Estados da definição do elenco de procedimentos de alta complexidade;
- (D) controle do cadastro nacional de prestadores de serviços;
- (E) formulação de mecanismos voltados à melhoria da qualidade dos serviços prestados.

18 - A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (SUS) – NOB/96 identifica quatro papéis básicos do gestor federal, **EXCETO**:

- (A) exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional;
- (B) promover as condições e incentivar o gestor estadual com vistas ao desenvolvimento dos sistemas municipais, de modo a conformar o SUS-Estadual;
- (C) fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais compondo, assim, o SUS-Nacional;
- (D) centralizar todas as ações de saúde no âmbito nacional;

- (E) exercer as funções de normalização e de coordenação no que se refere à gestão nacional do SUS.

19 - É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde:

- (A) Ministério da Saúde;
- (B) Fundo Municipal de Saúde;
- (C) Conferência de Saúde;
- (D) Secretaria de Assistência à Saúde;
- (E) Secretaria de Vigilância à Saúde.

20 - Segundo a Lei nº 8142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), a Conferência de Saúde deve reunir-se a cada:

- (A) ano;
- (B) dois anos;
- (C) três anos;
- (D) quatro anos;
- (E) cinco anos.

21 - A realização das funções de controle e avaliação em saúde devem ser feitas:

- (A) pela Presidência da República;
- (B) por todos os níveis do sistema de saúde;
- (C) pelo órgão específico do Ministério da Saúde;
- (D) pelos governos estaduais;
- (E) pelos conselhos comunitários.

22 - Segundo a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 01/2002 –, os municípios poderão habilitar-se à gestão do sistema de saúde de forma:

- (A) plena;
- (B) semiplena;
- (C) plena somente em relação à atenção básica ampliada;





PROVA OBJETIVA

- (D) semiplena somente em relação à atenção básica ampliada;
- (E) semiplena somente em relação à atenção terciária.

23 - Segundo a Lei nº 8080/90, constitui um critério para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e municípios:

- (A) participação paritária dos usuários no conselho de saúde;
- (B) prioridade para o atendimento hospitalar;
- (C) desempenho técnico, econômico e financeiro no período atual;
- (D) eficiência na arrecadação de impostos;
- (E) perfil epidemiológico da população a ser coberta.

24 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único que visa:

- (A) o atendimento voltado para atividades preventivas;
- (B) o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- (C) apenas ações de promoção da saúde;
- (D) apenas ações de prevenção secundária;
- (E) o atendimento voltado apenas para as atividades assistenciais.

25 - **NÃO** se inclui entre os objetivos do Sistema Único de Saúde:

- (A) identificação dos fatores determinantes da saúde;
- (B) formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a redução de riscos de doenças e de outros agravos;
- (C) assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a

realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;

- (D) divulgação dos fatores determinantes da saúde;
- (E) participação prioritária da iniciativa privada na assistência à saúde.

TECNICO DE SUPORTE A SAÚDE / PSICÓLOGO

26 - As políticas de saúde mental preconizam a reestruturação da assistência, priorizando o atendimento ambulatorial e a promoção da saúde mental através das ações básicas da saúde e da integração com a comunidade. Sobre as ações de saúde mental na comunidade, é correto afirmar que:

- (A) essas ações podem ter lugar em grupos organizados, como os grupos de auto-ajuda e organizações não governamentais;
- (B) programas de prevenção e informação desenvolvidos nas escolas não são considerados ações de saúde mental;
- (C) o desenvolvimento de ações de saúde mental comunitária depende da atuação de psicólogos ou psiquiatras;
- (D) a melhoria na saúde mental da população é resultante da maior oferta de atendimento psicológico ambulatorial;
- (E) ações de saúde mental comunitária devem sempre ser desenvolvidas em consultórios e postos de saúde.

27 - Alucinações auditivas e delírios de perseguição são sintomas clássicos de:

- (A) transtornos de personalidade de tipo paranóide;
- (B) todos os tipos de esquizofrenia;
- (C) transtornos de humor;
- (D) esquizofrenia paranóide;
- (E) transtornos obsessivos compulsivos.





PROVA OBJETIVA

28 - O psicólogo no hospital geral tem diversos níveis de atuação e atribuições, entre as quais **NÃO** se encontra a de:

- (A) participação em estudos de caso junto a equipes multiprofissionais;
- (B) transformação psíquica do paciente através da elaboração dos conflitos inconscientes responsáveis pela doença;
- (C) preparação psicológica dos pacientes para os procedimentos médicos;
- (D) oferta de suporte emocional aos familiares para o enfrentamento de situações específicas;
- (E) compreensão das tensões que acometem a equipe assistencial em sua prática.

29 - O psicólogo é muitas vezes solicitado a apresentar informações documentais decorrentes de avaliações psicológicas. Na produção desses documentos, o sigilo profissional pode ser colocado em risco pela presença de:

- (A) informações detalhadas sobre a história de vida e estados psicológicos do examinando;
- (B) informações sobre o referencial teórico científico adotado pelo profissional;
- (C) resultados das investigações com o posicionamento do psicólogo em resposta às questões levantadas;
- (D) identificação do solicitante do documento e do motivo do pedido;
- (E) identificação do autor do documento com número de inscrição no Conselho, titulação e assinatura.

30 - Em sua prática profissional, o psicólogo deve ser capaz de identificar situações de violência doméstica, que se manifestam como violência física, psicológica, sexual e negligência. Com relação à violência doméstica, é correto afirmar que:

- (A) o abuso de substâncias entorpecentes está sempre presente nas situações de violência doméstica;
- (B) a maior parte dos autores de violência sexual é conhecida da vítima;
- (C) a negligência é uma consequência da carência material da família;
- (D) o emprego de castigos físicos na educação de crianças não é considerado violência doméstica;

(E) a violência psicológica é característica dos portadores de doenças mentais.

31 - O Projeto de Lei Paulo Delgado tornou-se o catalisador dos debates acerca da questão antimanicomial. **NÃO** consta das propostas apresentadas por esta Lei:

- (A) o restabelecimento dos direitos civis e políticos dos doentes mentais;
- (B) a extinção progressiva de instituições com características asilares;
- (C) a necessidade de laudo médico para o tratamento em regime de internação;
- (D) a proibição sumária da internação compulsória;
- (E) o direito à informação a respeito da doença e do tratamento.

32 - Considerando a avaliação psicológica de pacientes portadores de deficiência mental, é correto afirmar que:

- (A) não existe tratamento para esses pacientes porque se trata de quadro decorrente de uma alteração genética irreversível;
- (B) a investigação dos fatores sociais, biológicos e psicológicos é necessária para um diagnóstico correto do quadro;
- (C) deficiências mentais são decorrentes de doenças metabólicas e devem ser tratadas por endocrinologistas;
- (D) deficientes mentais não têm capacidade de responder à testagem psicológica;
- (E) os conceitos de doença mental e deficiência mental são equivalentes na nosologia psiquiátrica.

33 - O estresse está na origem de uma série de processos psicossomáticos e é tema de grande interesse na psicologia contemporânea. Pode-se afirmar a respeito do estresse que:

- (A) é sempre negativo e patológico para o organismo e se manifesta psicologicamente como depressão e pânico;
- (B) é uma ocorrência fisiológica oriunda da não adaptação do organismo a uma nova situação, física ou psíquica;
- (C) em crianças, pode se manifestar através do agravamento de doenças físicas pré-existentes;





PROVA OBJETIVA

- (D) o estresse ocupacional é determinado exclusivamente por fatores externos ligados ao ambiente de trabalho;
- (E) úlcera péptica, hipertensão arterial e lesões miocárdicas são exemplos de doenças psicossomáticas imunes à ação do estresse.

34 - O hospital geral constitui um campo de trabalho relativamente novo para o psicólogo, que requer uma reflexão sobre o binômio saúde/doença e sobre sua prática profissional. Com relação ao trabalho do psicólogo junto às equipes de profissionais do hospital, é correto afirmar que:

- (A) a introdução da psicologia no campo da saúde confirmou a hegemonia do saber psicológico sobre o saber médico;
- (B) o psiquismo do indivíduo doente deve ser sempre trabalhado a partir de uma concepção abstrata e a-histórica;
- (C) o discurso naturalista da medicina enfatiza e legitima as dimensões simbólica, ética e política do processo saúde-doença;
- (D) as ciências humanas introduzem outros saberes no campo da saúde, mantendo, no entanto, a hegemonia do saber médico;
- (E) a interdisciplinariedade busca a interlocução entre os diversos saberes, questionando a hegemonia do saber médico.

35 - O adoecer físico mobiliza no paciente reações emocionais que variam de acordo com uma série de características da doença e do próprio indivíduo. Sobre as reações emocionais comumente observadas no paciente, é correto afirmar que:

- (A) o pensamento mágico consiste na recusa parcial ou total da percepção do fato de estar doente;
- (B) a reação de regressão dificulta a prestação de cuidados médicos ao paciente;
- (C) os sentimentos de raiva provocam no paciente uma necessidade de isolamento e um quadro de apatia;
- (D) a depressão decorrente da perda da saúde leva o paciente a minimizar a gravidade de seu problema;
- (E) a aceitação é resultante da adaptação à realidade da doença e da própria finitude.

36 - O consumo de substâncias psicoativas tornou-se um problema de saúde pública que atinge uma camada da população cada vez mais jovem. Com relação à prevenção na área de drogas, é correto afirmar que:

- (A) a prevenção terciária busca a redução de riscos através de medidas de reabilitação voltadas para os dependentes químicos;
- (B) as estratégias de prevenção primária têm como público alvo pessoas que já usaram drogas de forma problemática;
- (C) as incapacidades funcionais e sociais decorrentes da dependência química não constituem mais objeto de ações preventivas, mas apenas de intervenções terapêuticas;
- (D) as estratégias de prevenção primária não se dedicam a jovens que não experimentaram drogas, pelo risco de despertar sua curiosidade e induzi-los à experimentação;
- (E) os programas de redução de danos têm como meta ideal a abstinência, mas admitem a adoção de estratégias para prevenir outros prejuízos associados ao uso.





PROVA OBJETIVA

37 - É comum nos hospitais gerais e ambulatórios clínicos a procura por parte de pacientes com queixas físicas relacionadas a condições emocionais. Quanto à classificação nosológica desses quadros é INCORRETO afirmar que:

- (A) nos transtornos conversivos, o sintoma físico ou déficit não podem ser explicados por uma condição neurológica ou médica geral;
- (B) o paciente hipocondríaco traz uma queixa persistente de estar com uma doença grave, apesar dos resultados negativos das investigações;
- (C) nas doenças psicossomáticas, a alteração orgânica é constatável, podendo a doença ser ou não influenciada por causas emocionais;
- (D) os transtornos de ansiedade normalmente combinam uma sintomatologia psíquica com disfunções neurovegetativas;
- (E) queixas de sintomas somáticos podem acompanhar os sintomas de tristeza e inibição global típicos da depressão.

38 - A implementação de uma rede de atenção psicossocial ao paciente psiquiátrico é fundamental para a concretização das propostas da Reforma Psiquiátrica. Com relação aos serviços de atenção em saúde mental, é correto afirmar que:

- (A) apenas as unidades básicas de saúde que contam com psiquiatras e psicólogos podem promover atividades relacionadas à saúde mental;
- (B) os núcleos de atenção psicossocial oferecem programas de cuidados intensivos a pacientes egressos de internação psiquiátrica;
- (C) os leitos psiquiátricos em hospitais gerais são destinados a internações provisórias até a transferência para o hospital psiquiátrico;
- (D) o atendimento em ambulatórios de saúde mental é reservado a crianças, adolescentes e adultos com diagnóstico de neurose;
- (E) no hospital dia, cabe ao psiquiatra o atendimento ao doente mental, sendo atribuição do psicólogo o acompanhamento familiar.

39 - O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu Art. 112, VII, em referência ao Art. 101, V, a aplicação pelo Juiz ao jovem infrator de medida de requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. Refletindo *criticamente* sobre este tipo de encaminhamento para tratamento psicológico, é correto afirmar que:

- (A) o caráter obrigatório do tratamento é um obstáculo para a implicação do jovem no processo terapêutico e um dilema ético para o psicólogo;
- (B) o tratamento psicológico cumpre o objetivo de reduzir desvios de comportamento, tendo então um duplo caráter – corretivo e preventivo;
- (C) os jovens infratores apresentam diagnósticos de transtorno de personalidade anti-social e borderline que requerem tratamento medicamentoso;
- (D) a demanda de terapia surge quando o jovem é informado de que os relatórios encaminhados ao Juiz não contêm informações sobre o ato infracional praticado;
- (E) a terapia obrigatória representa uma oportunidade para o jovem infrator de se recuperar e reeducar no sentido de uma adaptação às normas sociais.

40 - No contexto brasileiro, a psicoterapia de grupo teve seu crescimento impulsionado pelas mudanças nas concepções e formas de atendimento em saúde mental, decorrentes dos movimentos de reforma psiquiátrica. A alternativa que justifica *ética e tecnicamente* a opção por esta modalidade de atendimento nos serviços de saúde mental é:

- (A) o atendimento em grupo responde às exigências de produtividade do terapeuta e dos ambulatórios públicos;
- (B) a política de desinstitucionalização psiquiátrica aumentou a demanda nos ambulatórios, inviabilizando a atenção individual;
- (C) o atendimento grupal em grupos de apoio apresenta vantagens de custo em comparação com as demais formas de terapia;





PROVA OBJETIVA

- (D) o atendimento grupal tem se revelado o modelo de atenção mais adequado às particularidades da clientela dos ambulatórios;
- (E) as políticas de atendimento em saúde mental preconizam atendimentos grupais e de curta duração como crítica ao modelo elitista psicanalítico.

PCI Concursos



REALIZAÇÃO